Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°3 PASS

UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 7 pages numérotées de 1 à 7 et comporte 1 QROC et 1 commentaire de texte.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot de votre RM :

Kakou kakou les péhunsss

Bravo, bravo, bravo. **Mille bravos** d'avoir terminé ce dernier tuto de SHS *(mon dernier enfant sniff...)*. Après **trois mois** de longues révisions à rêver de Canguilhem et de Claude Bernard vous vous lancez dans la dernière ligne droite : **the road to l'examen** 🥳 !!

Le chemin que vous avez parcouru est **phénoménal**, et ce dernier entrainement, *qui j'espère vous a apporté joie et bonheur*, en est la preuve. Imaginiez-vous seulement il y a quelque mois à peine être capable de rédiger trois pages en 1h30 sur un texte de **sciences humaines et sociales** ? Encore une fois, ne laissez pas votre note définir votre progrès et votre réussite. C'est normal si vous n'aviez pas encore pu voir tous les cours, vous allez **avoir le temps** de tout revoir avant le jour J ! Et j'insiste une dernière fois sur l'importance de *liiire* cette **magnifique correction** pour être les experts de l'analyse de texte en SHS.

On espère, avec Myrtille, que vous avez apprécié les **3 tutos et GTs** et tous les autres supports qu'on a pu vous mettre à disposition !! On est hyper fier de vous et de votre réussite et on vous envoie **TOUTE NOTRE FORCE** pour la suite !!

Benjamin, qui est **R**éellement **M**élancolique d'**E**crire cette dernière **B**outade

QROC

Expliquez en quoi consiste la solidarité nationale. (10 lignes)

Correction de la QROC

La solidarité nationale est un principe instauré par la loi Kouchner de 2002. Elle permet la prise en charge de certains dommages médicaux à travers la création de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Les dommages concernés sont tous les accidents médicaux non fautifs imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin (aléa thérapeutique), les infections nosocomiales supérieures à 25% de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), et les cas spéciaux de solidarité sans seuil de gravité (comme la vaccination obligatoire). Le dommage doit respecter un critère de gravité et doit être anormal par rapport au résultat escompté.

Commentaire de texte

Dans les maladies rares, [l']éventualité [de la guérison] est loin d'être la plus fréquente. La recherche se limite encore le plus souvent à celle de l'identification du gène responsable de la maladie. Les propositions thérapeutiques permettant une véritable guérison au niveau de la lésion du gène sont encore très réduites, les thérapies substitutives géniques ou cellulaires restant des pistes de recherche encore trop limitées. [...] Le diagnostic de ces maladies est le plus souvent difficile, avec des erreurs, des hésitations et des retards. Au bout de la chaîne, les propositions thérapeutiques n'en sont encore qu'à leurs prémices, par « essais thérapeutiques » successifs. [...].

Pour Canguilhem,[...] « Le malade n'est pas anormal par absence de norme mais par incapacité d'être normatif », c'est-à-dire de s'adapter à des changements de situations nouvelles en instituant des normes nouvelles[.] [...] Dans ce sens, les personnes touchées par une maladie rare d'origine génétique ne s'estiment pas malades puisqu'elles ont toutes – avec plus ou moins de difficultés et de temps – adopté une autre « allure de vie », en fonction de ce qui leur est possible de faire. C'est le vivant qui trouve en lui cette capacité d'adaptation, ce qui invite la médecine à soutenir modestement cette capacité. Cette forme nouvelle de la norme est envisagée non seulement par rapport aux écarts avec la forme antérieurement connue, mais également selon ses capacités à « trouver les conditions d'existence dans lesquelles elle paraîtra normative ». C'est là que toutes les ressources de la personne et de son entourage sont mobilisées pour manifester la volonté de vivre l'épreuve, sans chercher à la nier ou à l'esquiver. Il s'agit, pour elle, de trouver la capacité « d'instituer de nouvelles normes », travail de normativité et d'individuation qui, pour Canguilhem, est en soi signe de la guérison sans chercher à retrouver un « comme avant » purement fantasmatique.

Boucand, Marie-Hélène (2018). « Des malades qui ne guérissent pas », *Une approche éthique des maladies rares génétiques : Enjeux de reconnaissance et de compétence (p. 137-147)*, Paris, Erès, pp. 137-147.

Consigne : En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, vous expliquerez quelles finalités la médecine doit actuellement poursuivre dans la prise en soin des maladies génétiques rares. Vous expliquerez en quoi la manière dont ces maladies affectent la vie des personnes touchées justifie ces finalités.

Propos introductif

Le texte est structuré en deux parties ; toutefois, le deuxième paragraphe est considéré dans deux aspects différents dans la consigne. Il faudra donc distinguer clairement les deux idées directrices de ce paragraphe. Cet extrait semble faire référence à trois des cours magistraux présentés : le CM7 « Définitions de la santé et de la maladie », le CM12 « Enjeux éthiques et sociaux des maladies chroniques », et le CM13 « Histoire de la génétique ». Plusieurs concepts mobilisateurs sont évoqués : gènes, maladies rares, normal, anormal, adaptation... Il sera important de les définir et de les situer, notamment dans un contexte épistémologique pour la partie génétique, car ces notions ne sont pas nécessairement explicitées dans le texte mais sont pourtant essentielles à sa compréhension. Le texte ne fait pas mention de la maladie chronique ; on pourra en discuter sommairement, mais il faudra faire attention à nous centrer sur la maladie génétique La première partie du texte nous invite d'abord à interroger l'état actuel des connaissances et des traitements des maladies rares génétiques. Le constat de leur insuffisance établi, il faudra nous intéresser à sa conséquence sur les malades. Pour cela, on partira de la définition de normal et de pathologique, pour expliquer en quoi la maladie perturbe intrinsèquement le cadre de vie de la personne malade. Ce changement de norme est aux prémisses de la dernière partie de ce commentaire, qui se focalise naturellement sur les solutions à ce problème. On n'hésitera pas à insister sur les acteurs de ce travail de soin et sur l'importance de l'individuation de la personne malade du fait de la spécificité de sa situation.

Correction du commentaire

Ce texte extrait du chapitre intitulé “Des malades qui ne guérissent pas » tiré de l'ouvrage Une approche éthique des maladies rares génétiques : Enjeux de reconnaissance et de compétence de Marie-Hélène Boucand est un texte de philosophie de la médecine.

Le thème de ce texte porte sur les finalités que l'on peut assigner aujourd'hui à la médecine dans la prise en soin des personnes atteintes de maladies rares génétiques. La génétique est une branche des sciences médicales qui naît au début XXème siècle, bien que la prise en soin des maladies génétiques soit une préoccupation de la deuxième moitié de ce siècle.

Quels sont les paramètres de la prise en soin des personnes souffrant de maladies génétiques rares ?

La thèse du texte affirme que la médecine dans ce contexte n'a pas pour finalité de rechercher la guérison, mais qu'elle a pour finalités premièrement d'améliorer le diagnostic, deuxièmement de poursuivre les recherches sur les thérapies, et troisièmement de soutenir la capacité normative des personnes malades.

Selon l'autrice, les maladies génétiques rares, de par la complexité de leur diagnostic et la rareté de leurs traitements, conduisent à une expérience spécifique de la maladie. Elles imposent aux personnes malades de changer leur norme de vie et de déployer une normativité propre en vue de mener une existence source de bonheur, tout en s'adaptant aux contraintes liées à la maladie.

La maladie génétique rare pose d'abord le problème du diagnostic et ensuite celui de la thérapie, qui souvent interdit à la médecine de poursuivre l'objectif de la guérison.

La génétique naît de l'évolution de la théorie mendélienne de l'hérédité, selon laquelle les ressemblances entre descendants d'une même famille seraient liées à la transmission de particules que Mendel nomme les « gènes » (l.2). Dans les années 1910, cette théorie fusionne avec la théorie chromosomique de l'hérédité, après que des scientifiques ont observé que certains caractères phénotypiques apparaissent souvent ensemble, formant des « groupes de liaison » qui reflètent une proximité des gènes sur le chromosome. Le chromosome est donc le support physique de l'hérédité. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que des progrès tangibles soient réalisés dans « l'identification du gène responsable de la maladie » (l.2-3). De nouvelles méthodes sont élaborées, telles que la cristallographie ou l'électrophorèse,

s'appuyant sur de nouveaux modèles expérimentaux comme les bactéries ou les virus, et permettent d'identifier l'ADN comme support de l'hérédité et de déceler sa structure en double hélice. C'est l'essor de la biologie moléculaire.

De nombreuses maladies sont caractérisées comme ayant une origine génétique, comme la drépanocytose. Il s'agit d'une déformation des globules rouges en forme de faucilles entraînant des crises douloureuses intenses et une mortalité précoce chez les porteurs homozygotes de la mutation. On entend par homozygote le fait que les deux allèles d'un même gène soient identiques. L'identification de cette maladie a permis d'allonger la longévité des personnes qui en souffrent.

En premier lieu, la personne atteinte d'une maladie génétique rare souffre souvent d'une errance diagnostique, c'est-à-dire d'une longue période entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, ces « retards » (l. 6) sont dus à de multiples consultations et examens auprès de nombreux professionnels, avant que le patient ne soit finalement orienté vers un spécialiste des maladies génétiques. Les symptômes ne sont que rarement spécifiques, les différents examens médicaux non-concluants et, de manière générale, la sensibilisation aux maladies génétiques rares quasi-inexistante, d'où les « erreurs » (l. 6) et les « hésitations » (l. 6) de la part du corps médical. C'est pourquoi l'annonce du diagnostic est souvent vécue comme un moment de délivrance par la personne malade. Ce sentiment est la conséquence de longs moments d'incompréhension, de doute et de fatigue mentale liés à la recherche de la maladie. C'est pourquoi le généticien Arnold Munnich considère le fait de nommer la maladie comme un soin en soi et comme la première étape de la prise en soi du malade. Rechercher et poser un diagnostic représente donc une finalité essentielle de la médecine dans le domaine des maladies rares.

En second lieu, dans beaucoup de maladies rares, les « propositions thérapeutiques » qui s'offrent restent souvent limitées : il n'existe, à ce jour, que très peu de traitements efficaces dans le domaine des maladies génétiques rares. Certes, des «thérapies substitutives géniques ou cellulaires» (l. 4) se développent et font l'objet de nombreuses recherches et « essais thérapeutiques» (l. 7), mais leur efficacité n'est ni systématique, ni inoffensive. Ces thérapies désignent l'ensemble de méthodes permettant de traiter une pathologie en introduisant des cellules souches contenant des séquences modifiées d'un gène induisant une pathologie. Les effets à long terme de ces traitements demeurent mal connus, les méthodes ne sont pas appliquées de manière indiscriminée et et le coût moyen varie entre 2 et 4 millions de dollars par patient. Une des finalités de la médecine dans ce domaine consiste donc à poursuivre la recherche de thérapies visant la guérison.

On peut prendre l'exemple de la phénylcétonurie, où la phénylalanine, un acide aminé, n'est pas éliminée de l'organisme et s'accumule, devenant toxique. Les malades doivent adapter leur régime pour réguler leur consommation de phénylalanine, ce qui conduisait au départ à sous-alimenter les patients. Désormais, ils doivent suivre un régime alimentaire médical tout au long de leur vie, ce qui n'est pas sans contraintes. On leur déconseille aussi d'avoir des enfants biologiques, car il existe un risque de transmission de la maladie à l'enfant pendant la grossesse.

On peut aussi reprendre l'exemple de la drépanocytose pour laquelle la recherche vise aujourd'hui à améliorer les thérapies géniques et les greffes de moelle osseuse qui visent la guérison. Mais, pour l'heure, les traitements (antalgiques, transfusions sanguines, antibiothérapies) visent à soulager les crises douloureuses et à prévenir et diminuer les séquelles de la maladie.

La prise en soin des personnes souffrant de maladies génétiques rares est donc un défi, à la fois pour le corps médical qui possède peu d'outils de diagnostic et de traitement et se retrouve dans une impasse scientifique, ainsi que pour les malades qui souffrent à la fois des symptômes de la maladie et, souvent, de l'absence de diagnostic.

Ainsi, dans ces maladies, la finalité de la médecine et des traitements n'est pas la guérison de la maladie au sens de son éradication, mais l'accompagnement de la personne dans sa vie avec la maladie, ou encore le soutien de sa capacité normative au sein de la norme de vie que lui impose la maladie. Il s'agit de « soutenir modestement cette capacité » (l. 13) – comme c'est d'ailleurs le cas dans les maladies chroniques en général.

En suivant la philosophie de Georges Canguilhem, le texte montre que ces finalités spécifiques de la médecine dans la maladie rare s'expliquent en définitive par l'expérience vécue par la personne malade, par la norme de vie que la maladie lui impose, et par la nécessité de soutenir sa capacité normative et de l'aider à mener une vie où elle invente et met en oeuvre ses propres normes de vie, conformément à ses propres valeurs ou aspirations (« il s'agit, pour elle, de trouver la capacité « d'instituer de nouvelles normes », travail de normativité et d'individuation » (l. 18-19). Ce que l'on pourrait appeler une vie en propre, une vie à soi.

La maladie génétique rare entraîne pour le sujet une difficulté d'adaptation à son milieu de vie, un défaut de sa capacité d'adaptation, de sa capacité à instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles (l. 8).

Canguilhem définit le normal ou la santé comme un ensemble de réactions biologiques, mais aussi psychiques et sociales quand il s'agit d'un vivant humain, qui permettent au vivant de s'ajuster aux variations de son milieu, de « s'adapter à des changements de situations nouvelles » (l.10) et d'y avoir un comportement inventif. Le normal ou la santé correspondent à une certaine souplesse, une capacité à changer de norme de vie. Ils désignent non seulement la capacité de s'ajuster aux variations du milieu (des changements de température, une baisse du taux d'oxygène…), mais aussi de modifier son milieu selon ses besoins et ses valeurs (construire un abri pour se protéger du froid, s'équiper de bouteilles d'oxygène…). Il s'agit donc d'une capacité d'invention normative et de structuration du milieu, et non de conformation passive ou de soumission au milieu. La santé, c'est la pleine possession de la capacité normative, de la normativité qui est partagée par tous les vivants.

À l'inverse, le pathologique est la privation de la normativité, l'« incapacité d'être normatif» (l.10) au sens d'être pleinement normatif. Le sujet est affaibli dans sa capacité de faire varier sa relation au milieu et de s'y adapter. Cela signifie qu'il devient vulnérable aux variations du milieu. Le pathologique n'est cependant pas l'absence de toute norme (l. 8) : c'est même la fixation du comportement du vivant à une norme, une relation unique, limitée et figée au milieu, qui le rend vulnérable à ses variations. Dans cette perspective, la personne atteinte d'une maladie génétique rare est contrainte d'adopter une nouvelle norme de vie, « une autre « allure de vie » » (l. 12) restreinte « en fonction de ce qui leur (lui) est possible de faire » (l. 12)).

Cependant, la maladie n'exclut pas entièrement la possession d'une certaine « capacité d'adaptation » (l. 13), d'une « capacité « d'instituer de nouvelles normes » » (l.18). La vie avec la maladie génétique rare, bien que synonyme de symptômes, de difficultés d'adaptation et de contraintes, n'exclut pas pour le malade la possibilité d'élaborer lui-même une norme de vie qui peut être satisfaisante pour ses besoins et son épanouissement. Cela signifie pour lui la possibilité de composer avec cette nouvelle norme de vie imposée, de contribuer à en définir les contours et les limites. Cela montre qu'il conserve une part de normativité, qui lui permet d'apprendre à vivre avec la maladie. Cette nouvelle « allure de vie » (l.13) se caractérise notamment par la kyrielle de micro-activités quotidiennes et de décisions prises par la personne malade (prendre ses médicaments, consulter, en parler à ses proches…) qui vont influencer sa santé et sa vie.

Parce que cette autre allure de vie ou cette nouvelle norme de vie demeure en partie normative, c'est-à-dire parce que la personne malade l'invente elle-même en fonction de sa maladie, parce qu'elle est son œuvre et qu'elle peut s'y épanouir, la personne peut ne pas s'estimer malade (l. 11). Le normal et le pathologique sont toujours définis relativement au sujet, ils sont toujours subjectifs. Par exemple, une personne souffrant de phénylcétonurie entretient un cadre de vie « normal » en suivant son régime alimentaire médical. Mais ce régime est très contraignant pour elle, d'autant plus à l'adolescence : calcul en permanence de la quantité de phénylalanine qu'elle ingère, préparation qui sent mauvais donc la personne s'isole pour manger... Cependant, si elle arrête de suivre son régime, elle peut être confrontée à des symptômes, éprouver la diminution

de sa normativité et son état pathologique. Elle se sent malade.

L'expérience du pathologique, le vécu subjectif douloureux de la maladie dans la maladie rare génétique peut venir d'un double écart, d'une part entre l'état antérieur de la personne, la «forme antérieurement connue» (l.16) et son état présent, et, d'autre part, entre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle souhaiterait faire sans pour autant nier sa maladie.

Par conséquent, la finalité de la médecine, comme de l'action du malade lui-même et de son entourage, est de lui permettre de vivre avec la maladie (« vivre l'épreuve » (l. 16)) tout en étant le plus normatif possible, en étant le plus possible à l'initiative de ses propres normes de vie.

Pour cela, le médecin doit comprendre le vécu singulier du malade, ses bouleversements identitaires, les remaniements dans ses normes de vie et ce qu'il considère comme normal. Il doit s'appuyant sur ses « ressources » (l. 15) et ses activités propres et sur celles de son entourage, sur le soin que le malade prend de lui-même et ses relations de soutien et de soin médicales et non-médicales.

En conclusion, les maladies génétiques rares constituent un défi pour la médecine. Les retards de diagnostic, les limites des traitements proposés et la détresse qu'elles causent sont des épreuves difficiles pour la personne malade et son entourage. Il ne faut pas négliger la situation particulière liée à la rareté même et l'isolement des patients et de leurs proches devant une maladie inconnue ou mal connue des professionnels de santé et invisible dans la société. Sa définition du normal disparue, la personne malade doit, accompagnée de ses proches et des professionnels de santé, en inventer elle-même une nouvelle et tenter de la faire correspondre à ses besoins, ses désirs, ses valeurs et son individualité. Comme dans des maladies chroniques plus fréquentes, la médecine doit donc soutenir la capacité normative des personnes malades. Pour cela, elle doit notamment favoriser l'empowerment, consistant à apprendre à vivre avec la maladie et à développer la capacité à prendre soin de soi et de sa santé en vue de reprendre le pouvoir sur la maladie et sur son existence. Les groupes et associations de malades jouent aussi un rôle important via les partages d'expérience, l'appropriation du corps et de la maladie, et la reconnaissance sociale des maladies rares.

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM SHS EB 2025-2026)

Relecteurs :
Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM EB SHS 2025-2026), Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM GT SHS 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Souad BENABDI (DFGSM2) et Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team SHesS**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM SHS GT 25-26) et Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM SHS EB 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP